

西咪替丁制剂与药物相互作用

华西医大附一院西藏成办分院 关新建 左长银

西咪替丁为组织胺 H_2 受体阻滞药,可抑制食物,组织胺或五肽胃必素等刺激引起的胃酸分泌。亦可降低胃蛋白酶的分泌,口服后迅速由小肠吸收,30 分钟即达有效浓度,并可维持此浓度约 4h,吸收后分布除脑组织外的全身组织,半衰期为 2h,血浆蛋白结合率为 15—20%,24h 有 40—70% 以原形从尿中排出,12h 即可排出口服量的 80—90%^[1]。本品主用于治疗活动性十二指肠溃疡,预防溃疡复发,对胃溃疡,反流性食管炎与应激性溃疡等均有效,亦可用于卓—艾(Zollinger—Ellison)综合症,消化道溃疡或糜烂引起的出血,不能接受口服者可静脉给药。

近年来本品的制剂发展较快,并开避了有效的新用途。同时,发现本品有药酶诱导作用,可降低同用药物在肝脏内的代谢作用,延缓同用药物的排出,增加它们在血中的浓度而至毒副反应增加^[2]。为合理使用本品及新制剂,防止药物相互作用对疗效的影响,达到用药安全,有效的目的,特将本品有关资料概述如下。

一、西咪替丁的新剂型及用途^[2,3,4]

新剂型:1. 西咪替丁缓释片(泰胃美)及针剂,2. 西咪替丁咀嚼片,3. 西咪替丁糊剂,4. 珍稀胃片,5. 复方西咪替丁片,6. 复方西咪替丁霜,7. 复方西咪替丁膜。

用途:新剂型中,1—5 种为口服、针剂供静注。用途同前。其中泰胃美的新用途^[2]:本品可促进自身玫瑰花结形成细胞数量增加,提高白介素-2 的水平和 NK 细胞活性,发挥调节机体免疫机能的作用,此外对带状疱疹和水痘、荨麻疹、心律失常、嗜酸性筋膜炎,前列腺增生症、溃疡性结肠炎、肠易激综合征、皮肤瘙痒等有良好治疗作用,但复方西咪替丁霜与复方西咪替丁膜为外用,其中霜为局部给药,治疗带状疱疹、荨麻疹、瘙痒症等。方法用生理盐水清洗患处,未干时将药膜贴于患处,1 次/d,第二次应用时将残留药膜用生理盐水洗净后再贴,其总有效率为 97%。

二、西咪替丁与其它药物的相互作用及处理建议^[5,6]

(一)相互作用使毒副反应增加的机理与处理意见:

1. 西咪替丁与阿托品,联用时可致抑制胃酸分泌的作用增强,但二者相似的 N 毒作用也随之加重,一般不宜合用。

2. 西咪替丁与林可霉素:联用使林可霉素血药浓度升高 19%,生物利用度升高 27%,肝肾功能不全患者和治疗浓度处于上限的患者不宜合用,若必须合用,应监测其血药浓度并酌减剂量。

3. 西咪替丁与氮霉素:联用有诱发缺铁性贫血的可能,不宜同用。

4. 西咪替丁与氨基糖甙类抗生素:合用能导致氨基糖甙类药物血药浓度升高,发生呼吸抑制或呼吸停止,不宜合用。

5. 西咪替丁与卡托普利:联用有引起精神病样症状的可能,若合用时应密切观察病人。

6. 西咪替丁与普萘洛尔:合用后使后者清除率显著降低,血药浓度升高 2—3 倍,可引起严重心动过缓,低血压、注意监测用药期间血药浓度,减少用量,对肝功不良患者,建议选用经肾排泄的萘羟心胺较为安全。

7. 西咪替丁与胺碘酮:二药合用后使胺碘酮血药浓度升高,但个体差异很大,应监测血药浓度为宜。

8. 西咪替丁与利多卡因:口服西咪替丁能使利多卡因 $T_{1/2}$ 延长,血药浓度增高,静注无此现象,二者必须合用时应酌情处理。

9. 西咪替丁与硝苯地平、尼索地平、地尔硫卓:合用影响后者代谢,使血药浓度升高,致舒张压降低,心率明显加快,必须合用时应减少后者各药用量的 30—40%。

10. 西咪替丁与异丙嗪、苯海拉明:联用使 H_1H_2 受体被阻断,运动后的血管扩张作用受抑制,可加重心绞痛及间隔性跛行行症状,不宜合用。

11. 西咪替丁与安定、咖啡因、大仑丁、卡马西平、茶硷、利眠灵、华法令类、抗焦虑与抗抑郁等药物

合用,可因西咪替丁的酶抑制作用,使后面同用药物各自毒副反应增高,不宜合用,否则应进行血药浓度监测,调整用药剂量。

12. 西咪替丁与吗啡:合用可使吗啡血药浓度升高,引起潜在性致病不良反应,如呼吸骤停,伴癫痫发作,神志错乱及全身抽搐等,二者不宜合用。

(二)相互作用引起降效的处理建议

1. 西咪替丁与酮康唑,四环素(口服)同用后,西咪替丁干扰同用药物的吸收,影响疗效不宜同用。

2. 西咪替丁与可乐定,米诺地尔、胍乙啶,同用时,西咪替丁拮抗后面药物的降压作用,不宜同用。

(三)有益的相互作用:西咪替丁与环丙沙星,阿莫西林,甲硝唑等抗幽门螺杆菌药物合用,可加速溃

疡愈合,减少复发。

参考文献

1. 张自宽等编。《中国药品实用手册》,中国医药科技出版社,1999 年 2 月,第一版,172—173。
2. 廖名龙等编。《实用新药应用手册》,四川科技出版社,1996,114。
3. 侯连兵。《常用药物新剂型及临床应用》。人民解放军出版社,1997 年 3 月,第一版,81。
4. 同参考文献 1。
5. 药典委员会编。临床用药须知,《中华人民共和国药典》,1995 版,237。
6. 杨福兴 陈宜彬主编。临床用药手册,四川科学技术出版社,1991,198。

乙胺丁醇引起过敏性紫癜 1 例

西藏林芝地区卫生防疫站 卓玛 次仁顿珠 曲吉卓玛

患者男性 52 岁,因咳嗽、胸痛、发烧、伴盗汗 3 个多月于 2000 年 6 月 1 日来我部就诊,留取即时、夜间、清晨三份痰标本进行涂片检查,结果为抗酸杆菌阳性(4+)。2000 年 6 月 2 日胸片诊断为双肺Ⅲ型结核伴右侧胸膜炎。2000 年 6 月 3 日按新发涂阳给予短化治疗,始治方案为 2HZE/4H₃R₃,采取强化期督导管理,于 2000 年 8 月 1 日隔 2 个月查痰结果仍为阳性(2+)细菌减少,延长强化期一个月,缩短续治期 1 个月,方案改为 3HRZE/3H₃R₃。2000 年 8 月 29 日患者自诉全身瘙痒,经检查发现患者四肢、躯干出现皮疹,当日停用所有的抗结核药物,并进行抗过敏药物治疗,于 8 月 31 日检查皮疹蔓延快而广泛,除四肢、躯干外,颈部、面部均出现皮疹,呈大块淤斑,伴发热,下肢水肿及眼结膜充血,无呼吸困难,立即将患者转往地区临床部作进一步的诊治,临床部及皮肤科当时诊断为牛皮癣。在严密观察下,继续使用抗过敏药物及对症治疗,患者瘙痒减轻,皮疹逐步减退,水肿也消退,遂诊断为药物性皮炎。

为证实何种抗结核药物引起过敏性反应,待患者所有症状及皮疹消退后,在征得患者同意及严密观察下,参照西藏麻结防治指南一书及现代结核病学(人民出版社)的相关内容,对患者进行了抗结核

药物的脱敏疗法,于 2000 年 9 月 29 日,使用 RFP、INH 各一周,未出现任何过敏反应。为了不影响病人的治疗效果,于 10 月 14 日继续使用续治期二种药,病人于第五个月、六个月末痰菌阴转,X 光胸片预防结核病灶有吸收。

为继续查出引起过敏反应的药物,于 2001 年元月 9 日开始使用 PZA、EMB 二种药物进行脱敏疗法,在使用 PZA 药物时未出现反应,使用 EMB 第一天 100mg,第二天 500mg 后患者于第二日晚睡觉前又感觉全身瘙痒、发热、四肢肿胀,经检查四肢、躯干出现类似前次发病的皮疹,面部、四肢水肿,考虑为 EMB 所引起的上述反应,停用 EMB,并进行抗过敏及对症治疗,患者症状缓解,恢复正常。

讨论:根据该患者服用抗结核药物出现的不良反应,经脱敏疗法后,判定该患者是 EMB 所引起的慢性过敏反应。由 EMB 引起的常见副作用为视神经炎及其它神经系统不良反应,过敏反应、药物皮疹、皮肤粘膜损害,严重时可发生剥脱性皮炎也有报道,而由 EMB 引起的慢性过敏反应较少见,作者认为该患者发生慢性药物过敏反应与个体差异和药物本身的副作用密切相关。